

11 肺腫瘍 tumors of the lung

A 腫瘍様病変 tumor-like lesion

到達目標

- 腫瘍様病変の代表的疾患名と病理学的分類を説明できる
- 特徴的な病因や画像や臨床像が説明できる

定義・病因・疫学

腫瘍様病変とは、肺内に単発あるいは多発する非腫瘍性の腫瘤ないし嚢胞を形成する疾患である。疾患の頻度はまれであるが、肺癌との鑑別が問題になるので注意が必要である。

病理分類・診断・治療

腫瘍様病変は、病理学的観点から分類すると理解しやすい(表1)。ここでは、主に炎症性疾患、感染症、異所性組織について、その特徴を解説する。

a IgG4 関連肺炎

血清IgG4の上昇と臓器へのIgG4陽性の形質細胞を含むリンパ球浸潤や花むしり様線維化、閉塞性静脈炎を特徴とする慢性炎症性疾患である。中高年の男性に好発し呼吸器症状はまれである。画像では、両側肺門/縦隔リンパ節腫大、気管支壁/気管支血管束の肥厚、小葉間隔壁の肥厚、結節などを認める。硬化性涙腺炎/唾液腺炎、自己免疫性膵炎、IgG4関連硬化性胆管炎、IgG4関連腎臓炎、後腹膜線維症などを合併する。治療はステロイドが奏効する。

b 限局性器質化肺炎

細気管支、肺泡道、肺胞内を器質化した滲出物が充填し、限局性の結節を形成した炎症性病変である。先行する呼吸器感染症の治癒過程の可能性も示唆される。ステロイドへの反応は良好であり、検診などで指摘される。末梢の孤発性結節では、辺縁不整や胸膜陥入像を呈することから、肺癌との鑑別が問題となり、外科的切除が選択されることもある。

c 硝子化肉芽腫

結節性の硝子化膠原線維からなる病変で、多発することが多い。感染や自己免疫との関連が示唆されている。画像上では多発の境界不明瞭な結節性陰影を認める。無症状の場合も多い。外科的切除が一般的な治療で、確定診断もつけられることになる。

d 気管支炎症性ポリープ

気管支内に生じる非腫瘍性のポリープである。通常

表1 主な腫瘍様病変の病理学的分類

炎症性病変	1) IgG4 関連肺炎、2) 限局性器質化肺炎、3) 硝子化肉芽腫、4) 気管支炎症性ポリープ
感染症	1) 抗酸菌症、2) 真菌症、3) 寄生虫症 など
多発性増殖性病変	1) テューモレット、2) 微小肺髄膜細胞様結節、3) 多発性小結節性肺胞上皮過形成
代謝障害	1) アミロイド症 (アミロイド結節)
異所性組織	1) 子宮内膜症
形態異常	1) 肺分画症、2) 肺動静脈瘻
その他	1) サルコイドーシス、2) 珪肺、3) 多発血管炎性肉芽腫症、4) リウマチ結節

は単発の病変であり、外傷や感染によって生じることが知られている。一般に、中高年の男性に多く、血痰や咳嗽を契機に発見される。中枢気道に発生することが多く、気管支鏡下で鉗子により摘出される。

e 感染症

抗酸菌症(主に肺結核、非結核性抗酸菌症)は、画像上、肺門リンパ節腫大、多発性小結節影、粒状影、空洞影円形無気肺、膿瘍など多彩な病変が認められる。喀痰検査や気管支鏡検査による診断が必要である。

真菌症(主にクリプトコッカス症、アスペルギルス症)やエキノコッカスは、画像的に結節陰影がみられ肺癌との鑑別が問題になる。

寄生虫症(主に犬糸状虫症や肺吸虫症)は、偶然単発の結節影として発見される場合が多い。多くは無症状であり、好酸球の増加がみられる。

f 子宮内膜症

肺および胸膜の異所性の子宮内膜組織で、多くは性成熟期の女性に生じるが、閉経後のホルモン治療中の女性にみられることもある。画像上は結節を示し嚢胞性変化を伴うこともある。診断は、月経周期に一致した血痰・咯血といった症状と、画像での月経周期による陰影の変化に基づいてなされ、病理組織学的に診断を得ることは難しい。治療は、骨盤内子宮内膜症の治療に準じた薬物療法が選択されるが、診断と治療を兼ねた外科的切除も考慮される。

文 献

- 1) 谷田部 恭ほか(編): 腫瘍病理鑑別診断アトラス肺癌, 第2版, 文光堂, 2022